

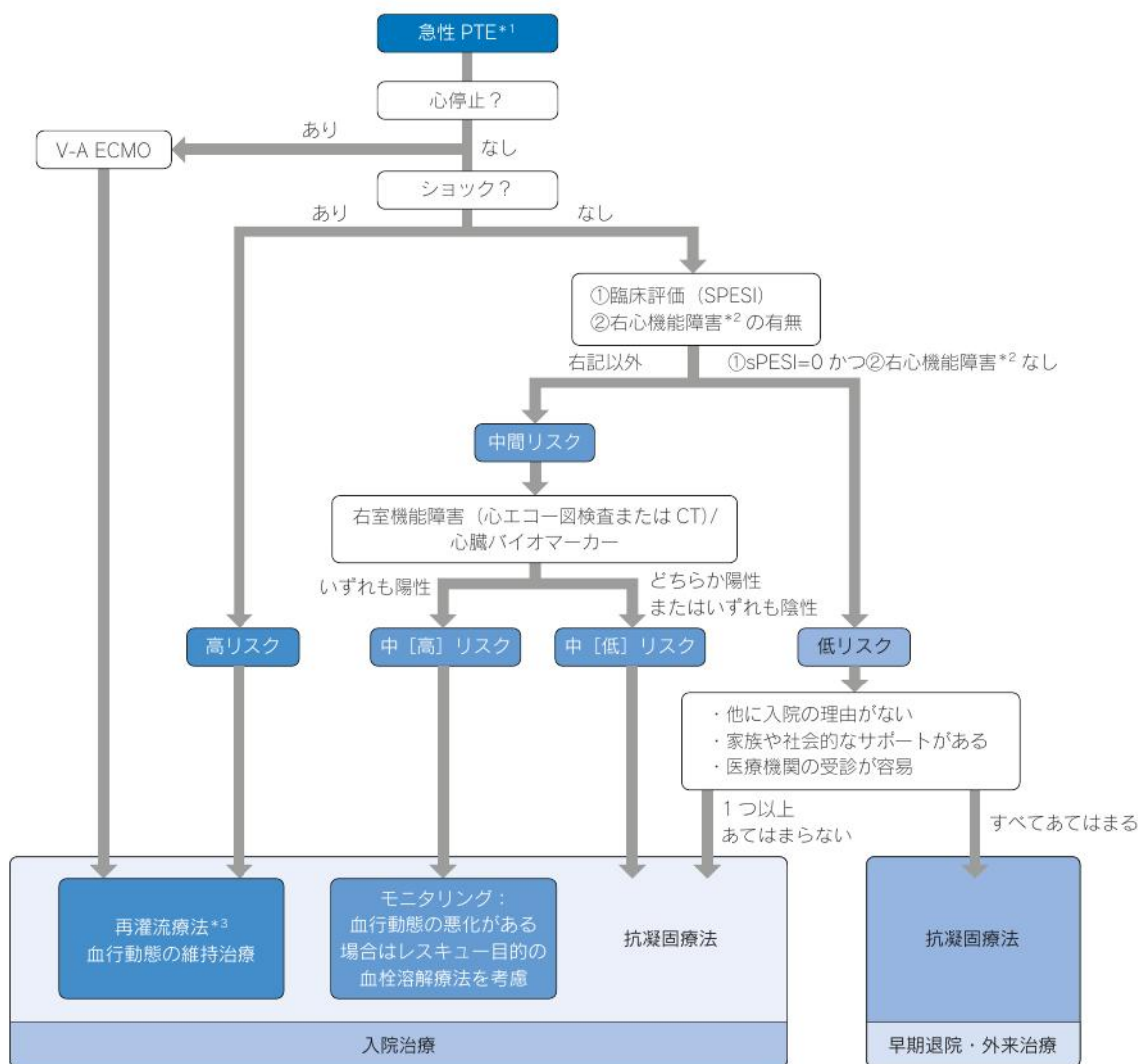


図4 急性 PTE の重症度別治療戦略

*1 外来治療を検討する際には、残存 DVT の治療などを適切に行い、PTE 再発時のリスクなどを十分に注意する。

*2 TTE または CTPA にて評価。

*3 血栓溶解療法、および施設の状況や患者状態により外科的またはカテーテル的血栓摘除術を検討する。

(Konstantinides SV, et al. 2020 を参考に作図)

[日本循環器学会/日本肺高血圧・肺循環器学会：2025 年改訂版肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症治療に関するガイドライン http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf (2026 年 2 月閲覧)]

動脈内膜摘除術 (PEA) が第一選択となる。また、末梢血栓例、高齢、合併症などで非手術適応となる例に対して、バルーン肺動脈拡張術 (BPA) が用いられ、良好な成績が報告されている。内科治療としては、在宅酸素療法、右心不全対策に加えて、非手術適応や術後残存、再発例に対して、肺血管拡張療法 (可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬の riociguat、選択的プロスタサイクリン受容体作動薬の selexipag) が用いられる。

c 肺梗塞

肺梗塞早期は出血と浮腫が病変の主体であり、その後吸収されて壊死部が瘢痕状に残存しつつ自然経過で

縮小するために、実臨床下では抗生剤加療により改善した肺炎と判断される症例が少なくない。肺梗塞そのものが重症化することはまれであり、治療の主体はその成因である DVT、急性 PTE に準ずる。

文 献

- 1) 日本循環器学会ほか：肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン (2017 年改訂版) http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_ito_h.pdf (2019 年 11 月 26 日閲覧)
- 2) Konstantinides SV, et al : Eur Heart J 35 : 3033, 2014